



Ya tenemos cita con la CALIDAD SUPERIOR • Vea la nota completa en P. 03
La acreditación es un tema CLAVE

1 DE NOVIEMBRE 2024 Ed. 194

#Somos HUN

BOLETÍN

Acreditación soy yo, acreditación
somos todos

Entérate del **HUN**  Lee nuestro boletín en **8 minutos**

Tabla de contenido



PP.

03 | Ya tenemos cita con la CALIDAD SUPERIOR



PP.

06 | HUN abre espacio hacia la Salud Digital



PP.

08 | Lanzamiento Estándar Clínico Basado en la Evidencia **Diagnóstico, estadificación, tratamiento y seguimiento del paciente adulto con cáncer de colon en el HUN**



PP.

12 | Lanzamiento Estándar Clínico Basado en la Evidencia **Prevención y tratamiento del dolor agudo postoperatorio del paciente adulto en el HUN**



PP.

16 | Lanzamiento Estándar Clínico Basado en la Evidencia **Diagnóstico y tratamiento del paciente adulto con insuficiencia cardiaca aguda en el HUN**



PP.

20 | Conoce la caracterización de la población en el HUN



PP.

21 | Calendario de eventos HUN



PP.

22 | Al día con la Dirección • Calendario

Ya tenemos cita con la CALIDAD SUPERIOR

Después de 7 años de trabajo hacia la calidad superior, 7 ciclos completos de mejora y 7 ejes que impulsan nuestro quehacer diario, ha llegado el momento de demostrar el mejoramiento continuo de nuestro hospital.

El ICONTEC designó un equipo de auditores, quienes del 19 al 22 de noviembre verificarán el cumplimiento de los estándares de calidad que garantizan una atención centrada en la persona, segura, eficiente y humanizada.

¿Qué evaluarán?

GESTIÓN CLÍNICA EXCELENTE Y SEGURA

Este proceso evalúa la gestión clínica, incluyendo la atención al paciente, la seguridad del paciente, el control de infecciones, y los resultados de salud, el equipo de auditores revisará procesos para garantizar que las prácticas clínicas se basen en evidencia y cumplan con normas de seguridad.

Acá será CLAVE la adherencia a GPC, protocolos y ECBE

PERSONAL ALINEADO AL DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA

El equipo de auditores verifica que el Talento Humano este alineado al direccionamiento y que entienda como contribuye la Misión, Visión, Objetivos y Proyectos estratégicos. La gestión administrativa y el uso de recursos, asegurando que el HUN tenga una administración eficiente que respalde la sostenibilidad del servicio y



Siguiente página

que haya un manejo adecuado de la infraestructura y los recursos financieros.

Acá será CLAVE la adherencia a la Misión, Visión, Proyectos estratégicos y funcionamiento de su proceso.

CALIDAD EN LA ATENCIÓN,
CENTRADA EN EL PACIENTE

ICONTEC analiza cómo nuestro hospital proporciona un servicio centrado en el paciente, lo cual implica que este reciba una atención digna, oportuna, y accesible. Se observa el trato al paciente, la privacidad, y la adecuación de la atención a las necesidades individuales. Esta evaluación se realiza a través de visitas a los servicios y paciente trazador.

Acá será CLAVE la Seguridad el Paciente, la comunicación entre procesos, la Humanización en la atención.

COMPETENCIA DEL
PERSONAL

Se evalúan las competencias y calificaciones del personal médico y administrativo, así como los programas de formación continua que la institución ofrece a su equipo.

Acá será CLAVE, los HITOS, el Plan de Capacitación Anual, el plan de bienestar y el modelo de CULTURA PRECISO

MEJORAMIENTO CONTINUO

Se revisan los sistemas de monitoreo, evaluación y mejora continua que permiten a la institución analizar y mejorar sus servicios y procesos. ICONTEC

buscará evidencias de un compromiso continuo con la mejora de la calidad.

Acá la clave será la implementación de la CLAVE, los equipos para la mejora EAE, EMI, EPM , comités y los logros del mejoramiento.

Súmate en este viaje
hacia la Acreditación

Llegó la hora de mostrar la Calidad superior que hace parte del ADN HUN. Invitamos a toda la comunidad a unirse en este viaje que nos llevará al cumplimiento de uno de los proyectos visionales y el Orgullo de ser parte de una Institución que mantiene vivo el compromiso por la salud, formación e investigación de Colombia.

ATERRIZAJES

Estas son visitas de 5 minutos que realizan los emisarios del equipo EMI a todos los procesos. Se realizan desde el 15 Octubre hasta el 15 de Noviembre.

DESPLIEGUE
SECUNDARIO

Esta es una reunión para conocer más a detalle el avance del hospital frente a los grupos de estándares que revisa

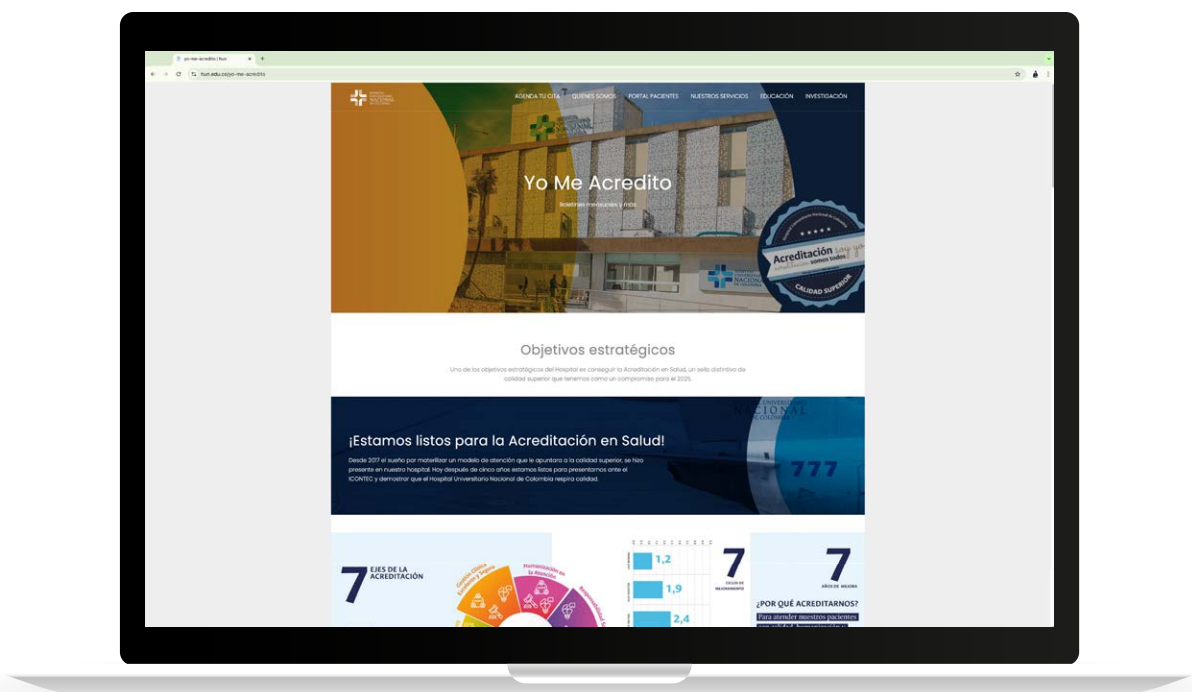
ICONTEC. Desde el 04 al 07 Noviembre en el salón A2, de forma continua desde las 7 am hasta las 4 pm, sesiones de 1 hora, lideradas por los integrantes del EMI. Asiste al despliegue secundario en el horario que te agendó tu líder de proceso o de manera

Invitamos a toda la
comunidad a unirse
en este viaje que nos
llevará al cumplimiento
de uno de los proyectos
visionales y el Orgullo
de ser parte de una
Institución que mantiene
vivo el compromiso
por la salud, formación
e investigación de
Colombia.

Siguiente página



voluntaria en los horarios establecidos hasta llenar los cupos de la sala. En este espacio se entregará la bitácora de viaje 2024 y el tiquete para participar de la III Feria de la Acreditación.



CONSULTA MÁS INFORMACIÓN 

III FERIA DE LA ACREDITACIÓN

Durante la feria podrás visitar 14 stand de cada grupo de estándares y los ejes de la Acreditación. Los stand estarán divididos en el Hall principal y los salones del edificio administrativo. Una vez tengas los sellos completos en el tiquete puedes depositarlos en la urna y participar por un viaje para dos personas todo pago para 3 días, 2 noches.



Desde el 12 al 15
Noviembre

#SomosHUN

VISITA DE EVALUACIÓN DEL ICONTEC

Del 19 al 22 de Noviembre

La bitácora ya está disponible en su versión digital para conocer mayor información <https://www.hun.edu.co/yo-me-acredito>



CONSULTA LA BITÁCORA 



Siguiente nota



HOSPITAL ESTANDARIZA es un tema **CLAVE**

HUN abre espacio hacia la Salud Digital

Con la experiencia derivada de TeleUCI Solidaria, en el marco de Conectando la Salud a la Región, proyecto conjunto de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y el Hospital Universitario Nacional de Colombia (HUN) se dio apertura a HUN DIGITAL, con capacidad para la atención de 7200 pacientes en modelo de telesalud.

HUN Digital se trata de una iniciativa orientada a la transformación digital en salud, que se basa en modelos de telesalud, que impactan a nivel regional en pacientes que tienen un difícil acceso, mejorando la cobertura, mejorando los diagnósticos tempranos, lo que termina impactando en modelos de salud pública, según lo comenta Jakeline Caro, médica especialista en gerencia en calidad de servicios de salud y jefe de Telemedicina del HUN.

Según lo comenta la Dra. Caro, se ha creado un espacio enfocado a telesalud , que incluye tele consulta, tele experticia, telemedicina interactiva y teleapoyo, lo que nos permite llegar a zonas rurales dispersas apoyando médicos que prestan su servicio rural obligatorio o personal asistencial que lleva mucho tiempo a nivel regional con manejo de guías, o protocolos desactualizados. Esto mejora el diagnóstico, el tratamiento, reduce las remisiones no necesarias y a su vez la pertinencia en la atención.

HUN Digital se trata de una iniciativa orientada a la transformación digital en salud, que se basa en modelos de telesalud, que impactan a nivel regional en pacientes que tienen un difícil acceso, mejorando la cobertura...

En alianza y articulación constante con NUEVA EPS, que hace presencia en todos los departamentos del país con más de 6 millones de afiliados, con un enfoque orientado a la atención primaria se han priorizado 6 regiones del país Amazonas, Guaviare, Guainía, Tumaco, Choco y la isla de San Andrés y providencia y se identifican las necesidades de remisión o referencia del paciente se informan para trasladar a un nivel de complejidad superior.

El programa inició el pasado 16 de octubre con 5 especialidades que son pediatría, cirugía general, psiquiatría, medicina interna y ginecología, enfocadas en la atención primaria en salud, luego si el paciente lo requiere se ofrecen las otras supra especialidades a través de tele medicina interactiva con el apoyo de la EPS, según comenta la Dra. Caro el HUN cuenta con 35 especialidades habilitadas para telemedicina.

Con la UNAL se tiene una articulación parcial, donde se está unificando el sueño por hospital que lleve a través de un modelo de tras territorialidad y equidad la salud a las regiones, se han abordado mesas de trabajo para continuar fortaleciendo lo que ya iniciamos con 5 cubículos específicos para telemedicina , en el proyecto de expansión se ha proyectado un área para el HUN Digital más robusta enfocada en innovación e investigación.

HUN Digital está compuesto por un equipo asistencial y administrativo que brinda atención 7 X 24, en un espacio de 48 mts 2, cinco cubículos específicos para telemedicina, un área de tele monitoreo para el seguimiento remoto de pacientes, que permite monitorizar las alertas de riesgo y el área de TeleUCI, que está inmersa en tele experticia. Su capacidad de atención es de 7200 consultas al mes.



HUN Digital



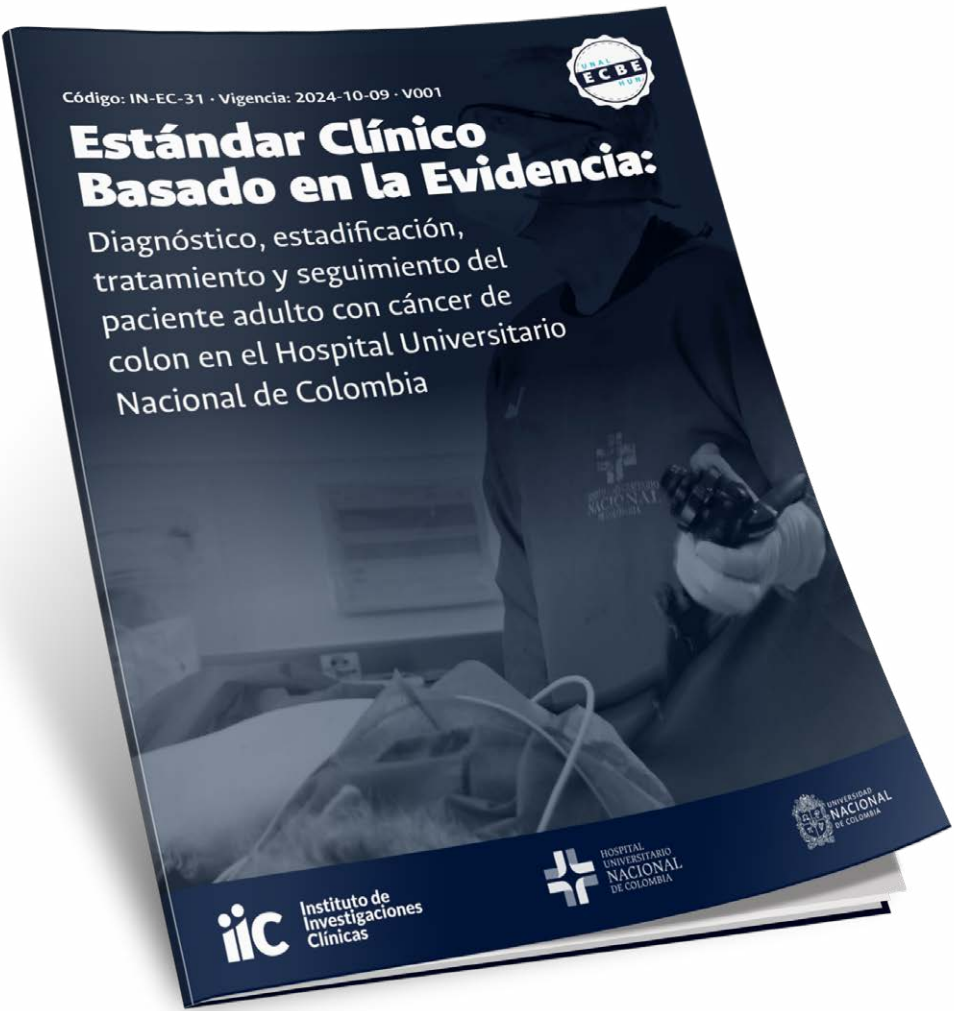
Siguiente nota

HOSPITAL ESTANDARIZA es un tema **CLAVE**

Estándar Clínico Basado en la Evidencia

Diagnóstico, estadificación, tratamiento y seguimiento del paciente adulto con cáncer de colon en el HUN

ECBE



Conoce más sobre
los ECBE

El cáncer colorrectal es el tercer cáncer más frecuente en hombres y el segundo en mujeres a nivel mundial según las estadísticas del Observatorio global del cáncer (GLOBOCAN) 2020, y se estima que se presentan anualmente alrededor de 900.000 muertes, siendo el segundo cáncer con mayor mortalidad.



Siguiente página

Un componente fundamental del proyecto estratégico
HOSPITAL ESTANDARIZA



ECBE diagnóstico, estadificación, tratamiento y seguimiento del paciente adulto con cáncer de colon en el Hospital Universitario Nacional de Colombia

Edgar Germán Junca Burgos y Rafael Enrique Tejada Cabrera
Líderes clínicos ECBE diagnóstico, estadificación, tratamiento y seguimiento del paciente adulto con cáncer de colon .

Puntos Clave

DIAGNÓSTICO

En pacientes con sospecha de cáncer de colon se debe realizar historia clínica completa haciendo énfasis en la detección de factores de riesgo, descripción y cronología de los síntomas, búsqueda de adenopatías palpables, masas abdominales o masas rectales, examen perineal y tacto rectal en casos de síntomas de obstrucción o sangrado gastrointestinal. Debe dejarse constancia de la evaluación desacondicionamiento físico.

Si persiste la sospecha se recomienda la solicitud de:

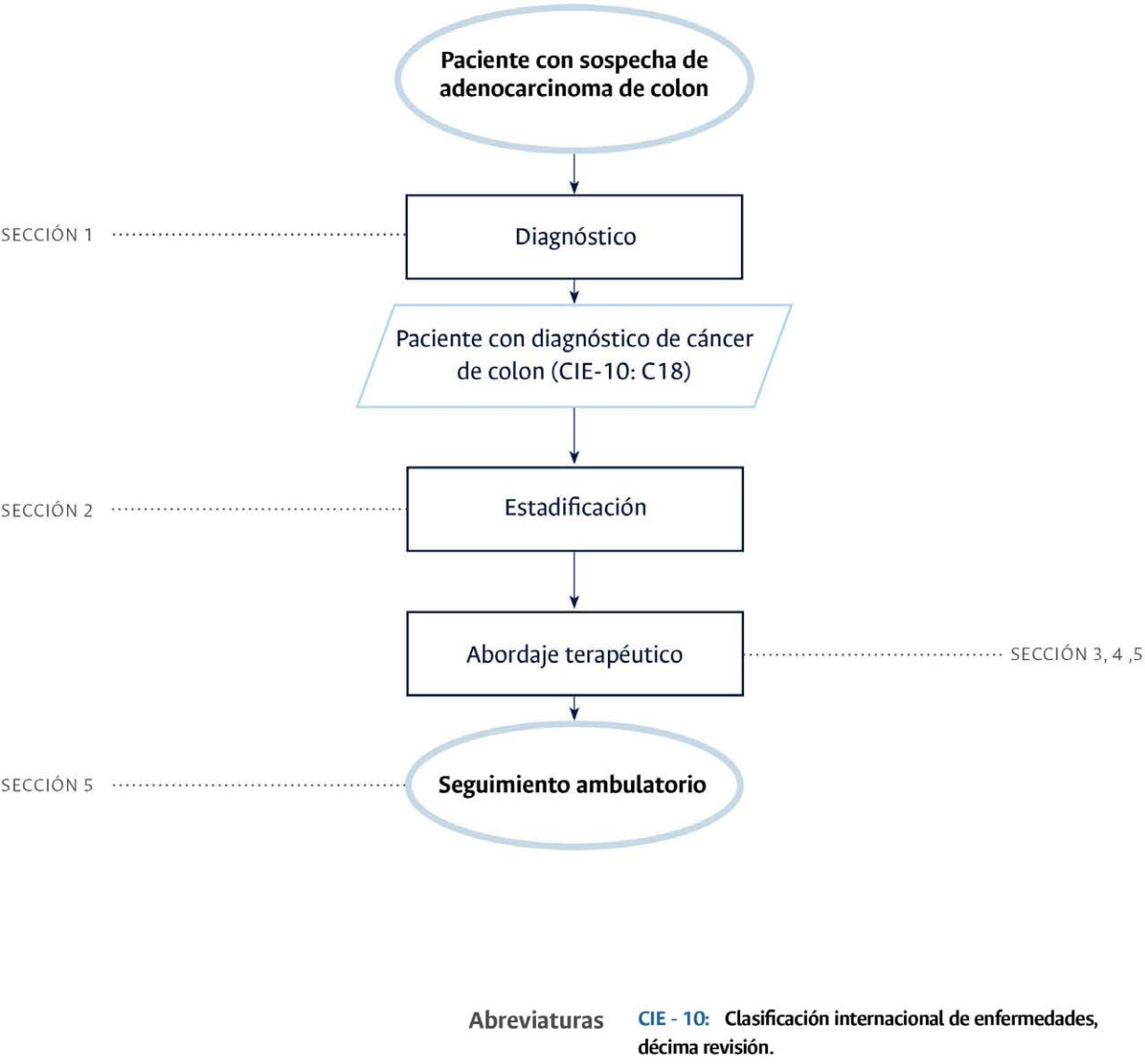
- Colonoscopia total
- Biopsias
- Inmunohistoquímica

Algunos diagnósticos diferenciales son: Colitis infecciosa, apendicitis aguda, enfermedad diverticular complicada, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, hemorroides, pólipos adenomatosos, enfermedad diverticular, otras neoplasias, trastornos linfoproliferativos, tuberculosis o VIH.

ESTADIFICACIÓN

Una vez confirmado el diagnóstico se debe solicitar marcadores tumorales (ACE y Ca 19.9) para seguimiento y pronóstico.

El estudio de elección para la estadificación en cáncer de colon es la tomografía computarizada (TAC) de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso.



**TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON
CÁNCER DE COLON ESTADIO LOCAL
O LOCO-REGIONAL**

El abordaje integral de todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de colon incluye:

- Consideración de comorbilidades y solicitud de valoración por los servicios pertinentes para acompañamiento y compensación de las mismas.
- Registro clínico del índice de comorbilidades de Charlson.
- Acompañamiento de salud mental, inicialmente con psicología para el afrontamiento del diagnóstico, el aprendizaje de herramientas emocionales para el paciente y la familia, y evaluación del requerimiento de valoración por psiquiatría.
- Valoración por el servicio de geriatría, para la evaluación de escalas de fragilidad y funcionalidad en pacientes mayores de 65 años.
- Se recomienda valoración por el servicio de medicina física y rehabilitación, con el fin de objetivar el desacondicionamiento y realizar una intervención temprana.
- En pacientes con dolor que no mejora con las primeras líneas de manejo, se debe solicitar apoyo por el servicio de dolor y cuidados paliativos para establecer un tratamiento multimodal.

Los pacientes candidatos a procedimiento quirúrgico requerirán de una valoración preanestésica, donde se realizará un balance entre el procedimiento propuesto

y los riesgos de cada paciente. El abordaje para el tratamiento quirúrgico depende del estadio, las posibilidades de resección quirúrgica son:

- Tradicional o endoscópica: Para T1b.
- Tradicional: Para T2 -T3 / N0-N+, T4/N2.

Se debe realizar un reporte completo de patología posterior a cualquier resección quirúrgica, para determinar con precisión la extensión del tumor por las paredes del colon o las estructuras adyacentes, la extensión del compromiso ganglionar o determinar la presencia de metástasis en lesiones sospechosas.

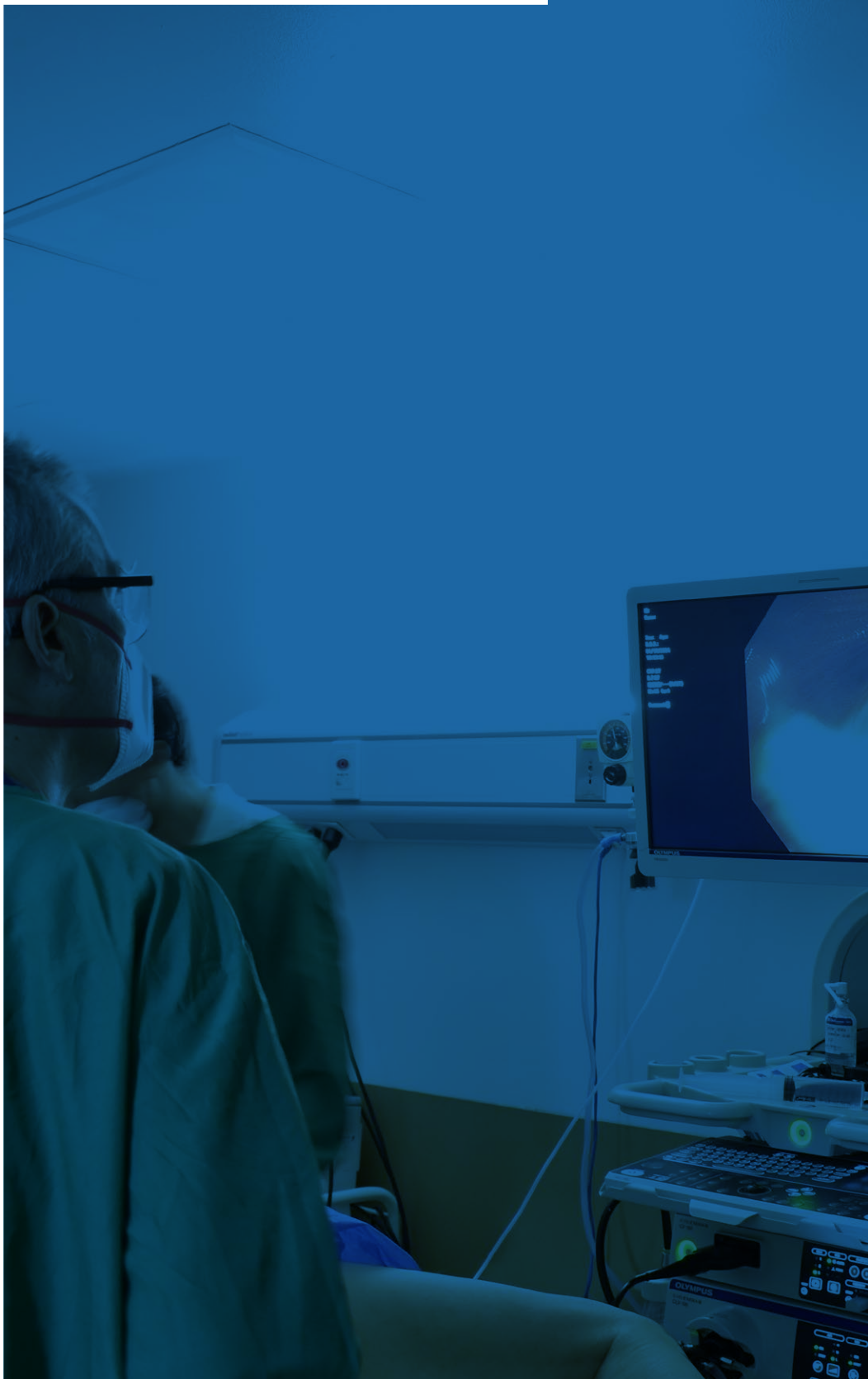
Los pacientes con pérdida de peso mayor al 5-10% tienen mayores las tasas de complicaciones, por lo que se recomienda la valoración nutricional.

**TRATAMIENTO DEL PACIENTE
CON CÁNCER DE COLON ESTADIO
AVANZADO**

En pacientes con cáncer de colon estadio IV, para establecer la conducta se recomienda definir el tipo de lesión así:

- Tumor primario resecable
- Tumor primario no resecable y no sintomático
- Tumor primario resecable con metástasis no resecable

Siguiente página



En caso de presentar cáncer de colon estadio IV y no ser candidatos a resección quirúrgica o tratamiento oncológico, se recomienda la valoración por el servicio de cuidados paliativos, continuar la intervención integral del paciente adaptado a sus necesidades y garantizar el acompañamiento al paciente, sus familiares y cuidadores al final de la vida.

TRATAMIENTO NEOADYUVANTE, COADYUVANTE

Se debe evaluar si el paciente se beneficia de quimioterapia neoadyuvante o paliativa, para lo que se recomienda la valoración por el servicio de oncología. Así mismo, se recomienda descartar la presencia del síndrome de Lynch y otras alteraciones genómicas. Previo al tratamiento neo o adyuvante, dada la toxicidad de los medicamentos quimioterapéuticos, se debe realizar evaluación del perfil de riesgo:

- **Cardiotóxicos:** pro-BNP, troponina, electrocardiograma, ecocardiograma transtorácico.
- **Hepatotóxicos:** transaminasas, bilirrubina total y directa, tiempos de coagulación.
- **Nefrotóxicos:** creatinina y nitrógeno ureico.

Como parte del perfil de seguridad, previo a una terapia sistémica se deben descartar complicaciones agudas y crónicas oncológicas, mediante la medición rutinaria de los siguientes paraclínicos:

- **Síndrome de lisis tumoral:** ácido úrico, potasio, fósforo, calcio.
- **Hipercalcemia maligna:** calcio, albúmina.
- **Anemia:** hemograma.

- **Ferropenia:** hierro sérico, ferritina, saturación de transferrina, capacidad de combinación del hierro (TIBC).
- **Hipo/hipertiroidismo:** hormona estimulante de la tiroides (TSH), tiroxina libre (T4L).

SEGUIMIENTO

Si el paciente tiene pronóstico curativo y fue llevado a resección endoscópica, se recomienda programar colonoscopia al año después de la resección; si no se encuentran hallazgos anormales, se puede dar alta del seguimiento.

Para el paciente con pronóstico curativo que fue llevado a resección quirúrgica, se debe continuar el cuidado integral y de ostomía, si lo requiere.

Durante los primeros 3 años se recomienda realizar:

- Examen clínico y medición de ACE y Ca-19.9 cada 3-6 meses
- TAC de tórax y abdomen cada 6 a 12 meses
- Colonoscopia al año y cada 3-5 años a partir de la cirugía

Durante los cuatro a cinco años siguientes se recomienda realizar:

- Examen clínico y medición de ACE y Ca-19.9 cada 6-12 meses
- TAC de tórax y abdomen cada 12 meses
- Colonoscopia al año cada 3-5 años

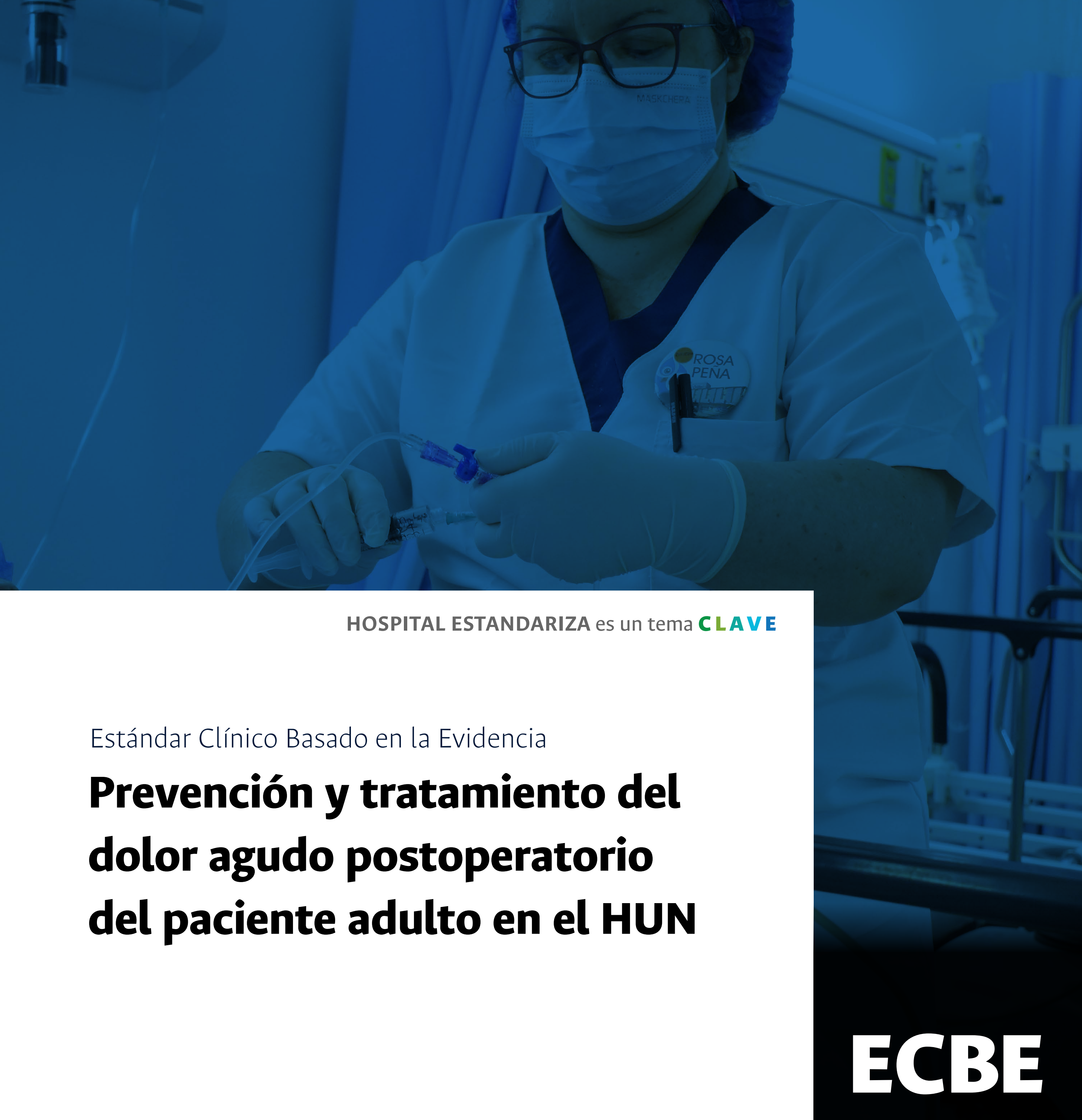
En casos de encontrar hallazgos anormales, se deben orientar la intervenciones de acuerdo a hallazgos de segundo primario o recaída tumoral.



Consulta el ECBE en la página web del HUN

<https://www.hun.edu.co/paciente-adulto-con-cancer-de-colon>

#SomosHUN

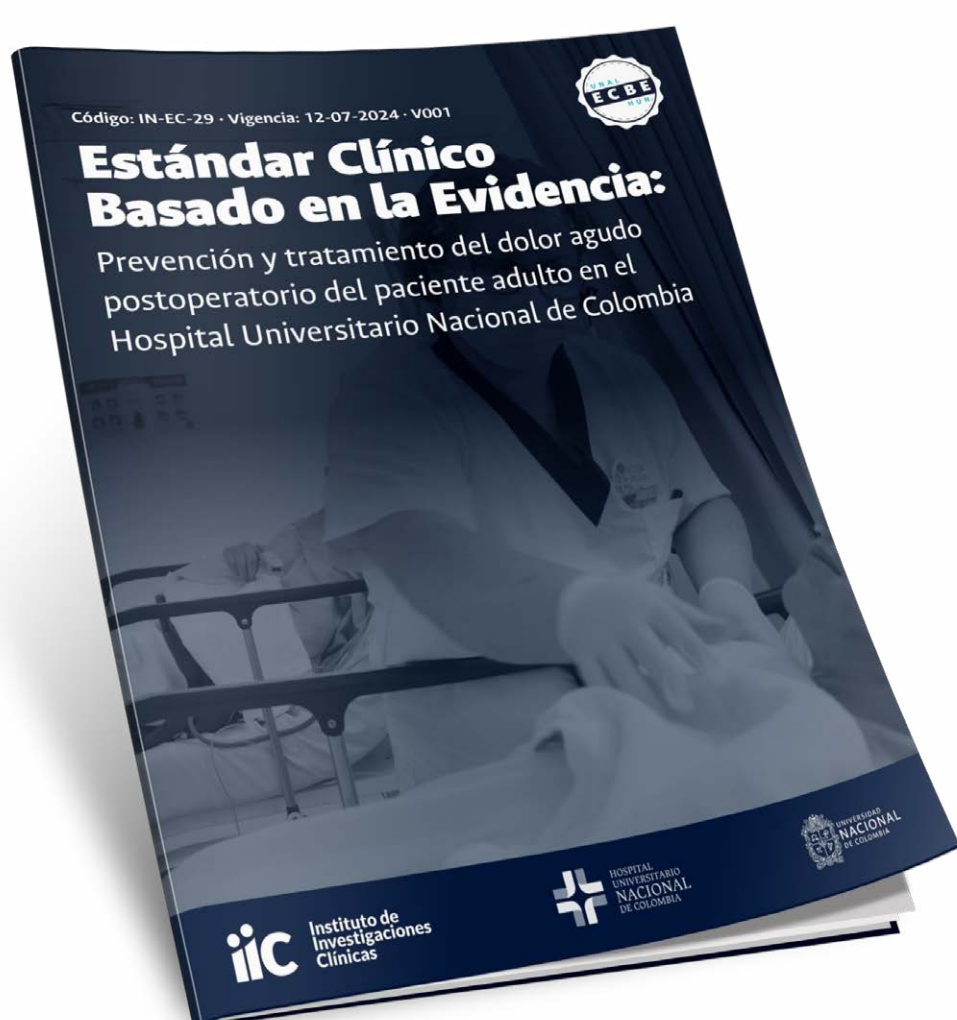


HOSPITAL ESTANDARIZA es un tema **CLAVE**

Estándar Clínico Basado en la Evidencia

Prevención y tratamiento del dolor agudo postoperatorio del paciente adulto en el HUN

ECBE



Conoce más sobre
los ECBE



El dolor agudo postoperatorio se define como la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial inmediatamente después de una cirugía o hasta 36 horas posteriores de la misma. Es una condición que desarrollan alrededor del 80 % de los pacientes que son llevados a procedimientos quirúrgicos, con niveles del dolor moderado/grave hasta en el 75 % de éstos y con mejoría del dolor a menos del 50 % una vez instaurado el tratamiento.

Siguiente página

Un componente fundamental del proyecto estratégico
HOSPITAL ESTANDARIZA

Prevención del dolor agudo

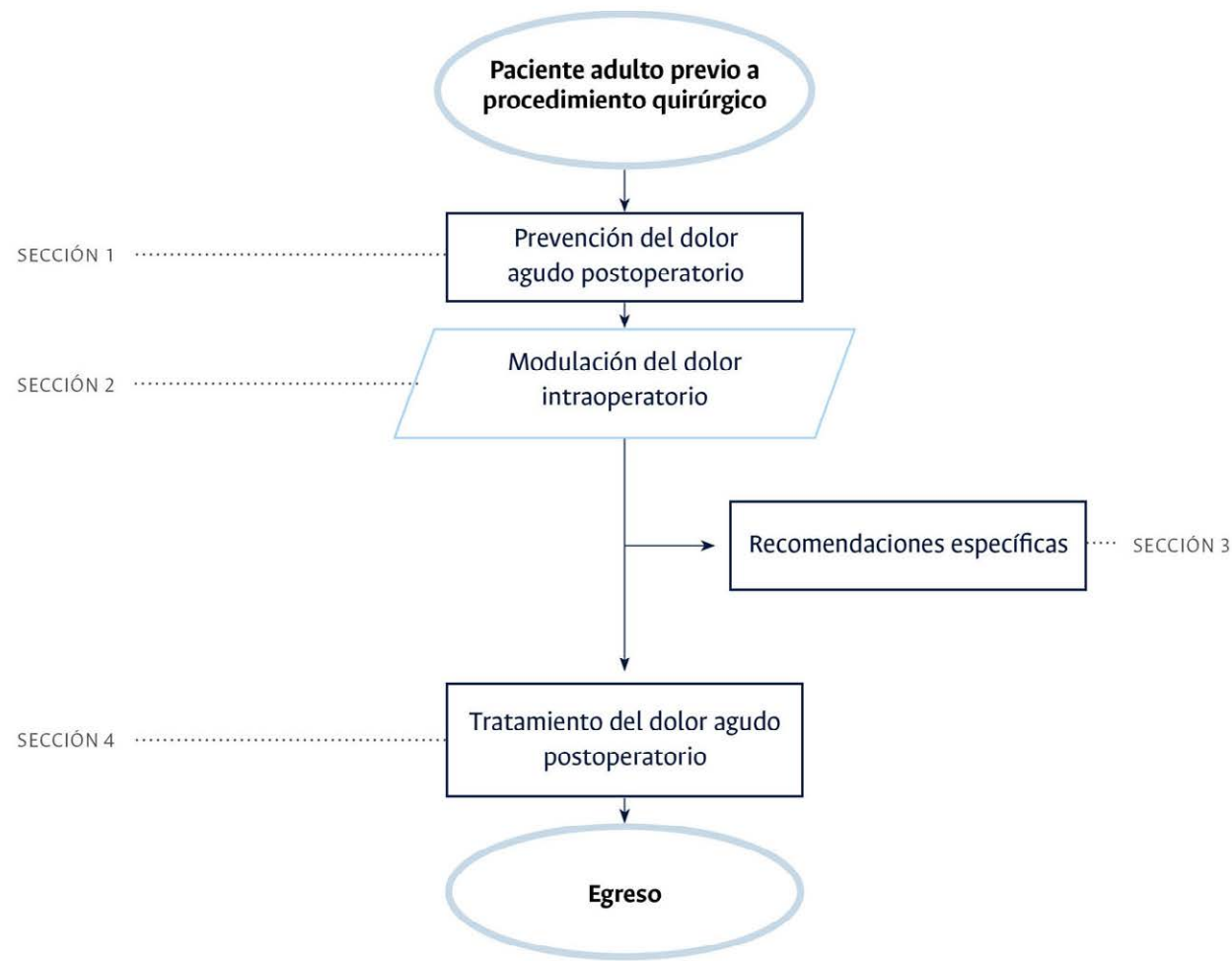
Previo al procedimiento quirúrgico se recomienda:

- **Realizar de valoración preanestésica y prequirúrgica.**
En el paciente que ha sido ingresado a preparación de cirugía, se recomienda la realización de valoración preanestésica, por parte del anestesiólogo a cargo en el procedimiento, con el fin de establecer un plan de tratamiento de dolor individualizado e identificar posibles riesgos del paciente para considerar la valoración por otros servicios según las necesidades. De igual forma, se recomienda la realización de valoración prequirúrgica por parte del equipo quirúrgico para dar una explicación detallada del procedimiento, riesgos, posibles complicaciones y verificación de consentimiento informado quirúrgico.
- **Proporcionar educación y apoyo individualizado al paciente, familia y cuidadores:** Se debe registrar su realización en la historia clínica del paciente por el servicio correspondiente.
- **Contemplar estrategias no farmacológicas para el tratamiento del dolor.**
- **Plan de tratamiento anestésico perioperatorio** que tenga en cuenta los antecedentes del paciente, la conciliación medicamentosa, ajustándolo según la respuesta clínica y la presencia de eventos adversos.



ECBE prevención y tratamiento del dolor agudo postoperatorio del paciente adulto en el Hospital Universitario Nacional de Colombia

Guillermo Enrique Ospino Rodríguez y Jenifer Paola Reina García
Líderes clínicos ECBE prevención y tratamiento del dolor agudo postoperatorio del paciente adulto.



Modulación del dolor intraoperatorio

Durante el procedimiento quirúrgico debe implementarse la analgesia multimodal perioperatoria y evaluar si existen recomendaciones específicas para el tratamiento del dolor según el tipo de cirugía.

una vez finalizado el procedimiento, si se tiene la posibilidad de evaluar la severidad del dolor del paciente, debe realizarse una evaluación periódica según la escala numérica del dolor:

< 4/10: se considera dolor postoperatorio controlado, se debe continuar la analgesia multimodal perioperatoria intrahospitalaria o ambulatoria y el tratamiento por el servicio tratante.

≥ 4/10: Se considera dolor postoperatorio no controlado

Se recomienda la valoración por el servicio del dolor y cuidado paliativo para el paciente durante el postoperatorio inmediato con alteración del sensorio en quien no es posible valorar la escala numérica del dolor.

Recomendaciones específicas

Existen recomendaciones específicas para la modulación del dolor en algunos procedimientos quirúrgicos. A continuación se mencionan los procedimientos de acuerdo a la especialidad que los realiza. Para profundizar en las recomendaciones, le invitamos a consultar el ECBE.

CIRUGÍA GENERAL:

- Herniorrafía inguinal
- Colecistectomía por laparoscopia
- Apendicetomía
- Cirugía colorrectal por laparoscopia

GINECOLOGÍA:

- Histerectomía por laparoscopia

ORTOPEDIA/NEUROCIRUGÍA:

- Manguito rotador
- Artroplastia de rodilla
- Cirugía de columna

Siguiente página



Tratamiento del dolor agudo postoperatorio

Frente al paciente con dolor posoperatorio no controlado, debe considerarse el uso crónico o inapropiado de opioides potentes. Para evaluar dependencia, se recomienda la solicitud de valoración por el servicio de psiquiatría en los siguientes escenarios:

- Dolor persistente que no mejora a pesar de realizar tratamiento interdisciplinar de primera línea
- Paciente con patología mental de base que pueda exacerbar cuadro de dolor.
- Paciente con riesgo o sospecha de trastorno mental por opioides o uso problemático de opioides.
- Paciente con antecedente o consumo activo de sustancias psicoactivas (alcohol, cigarrillo, cannabis, cocaína, anfetaminas, hidrocarburos, etc.) o medicamentos con riesgo de generar dependencia (benzodiacepinas, opioides, estimulantes).
- Síntomas afectivos, comportamentales, cognitivos, psicóticos asociados a pobre control del dolor.
- Cuando se considera componente mental o psicosocial que pueda estar exacerbando el dolor.

Si no se tiene antecedente de uso crónico o inapropiado de opioides potentes, se debe considerar otras técnicas multimodales y el escalonamiento titulado de analgesia según el tipo de cirugía. Una vez establecida la alternativa terapéutica, se recomienda la evaluación periódica

de la escala numérica del dolor para determinar conductas como:

- Revaloración por el equipo quirúrgico si el dolor persiste con una severidad $\geq 4/10$
- Continuar tratamiento por el servicio tratante si el dolor ha sido modulado ($<4/10$)

El dolor agudo postoperatorio se define como la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial inmediatamente después de una cirugía



Consulta el ECBE en la página web del HUN

<https://www.hun.edu.co/dolor-agudo-postoperatorio-del-paciente-adulto>

#SomosHUN

Siguiente nota

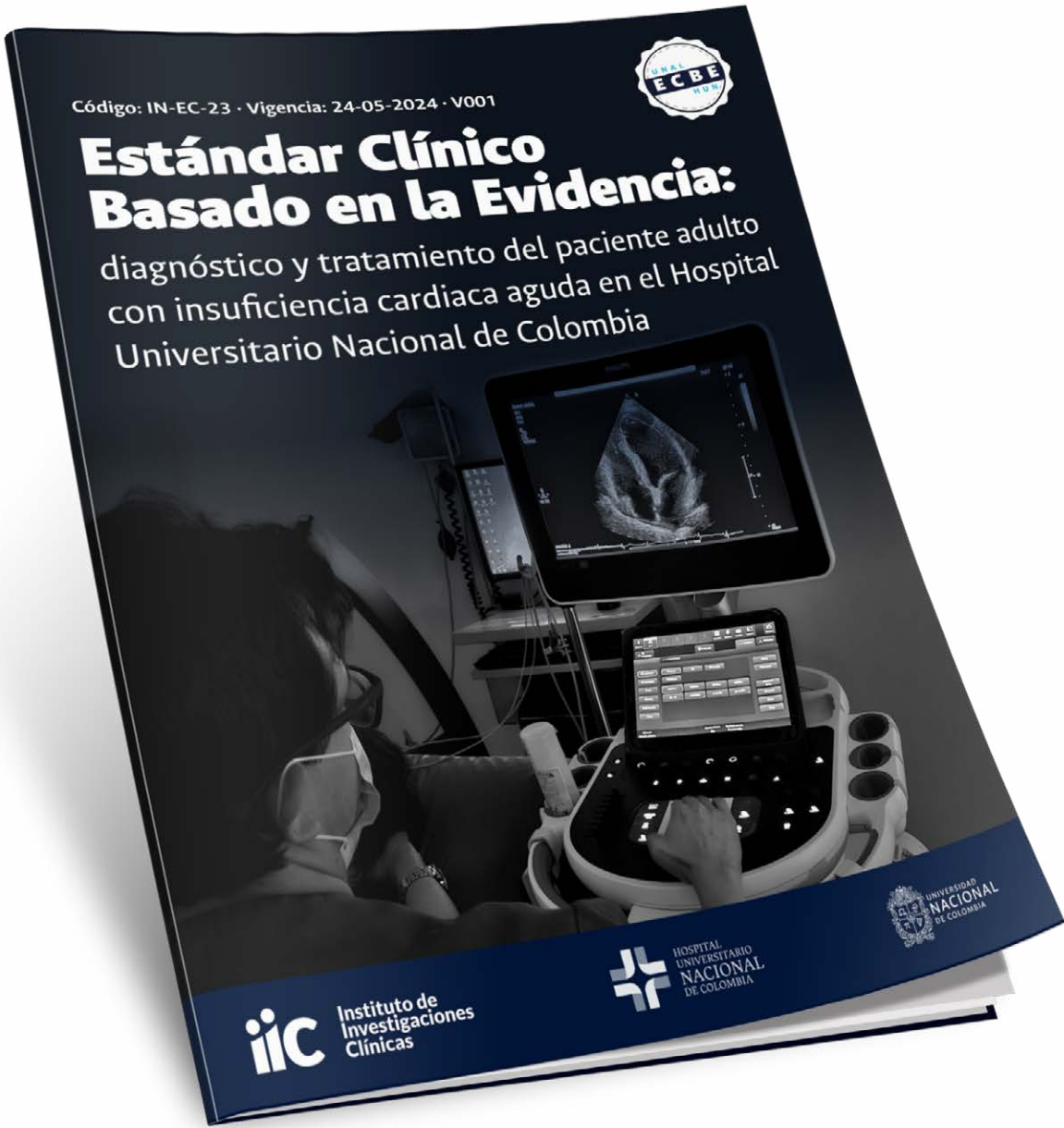


HOSPITAL ESTANDARIZA es un tema **CLAVE**

Estándar Clínico Basado en la Evidencia

Diagnóstico y tratamiento del paciente adulto con insuficiencia cardiaca aguda en el HUN

ECBE



Conoce más sobre
los ECBE 

La insuficiencia cardiaca es un síndrome clínico que comprende signos y síntomas secundarios a anormalidades funcionales o estructurales del corazón. Según su temporalidad, la insuficiencia cardiaca puede clasificarse como crónica o aguda. Por su parte, la insuficiencia cardiaca aguda (ICA) se define como la aparición o empeoramiento de signos y síntomas que puede presentarse en pacientes con o sin diagnóstico previo de insuficiencia cardiaca.

Siguiente página

Un componente fundamental del proyecto estratégico
HOSPITAL ESTANDARIZA

Puntos Clave

DIAGNÓSTICO

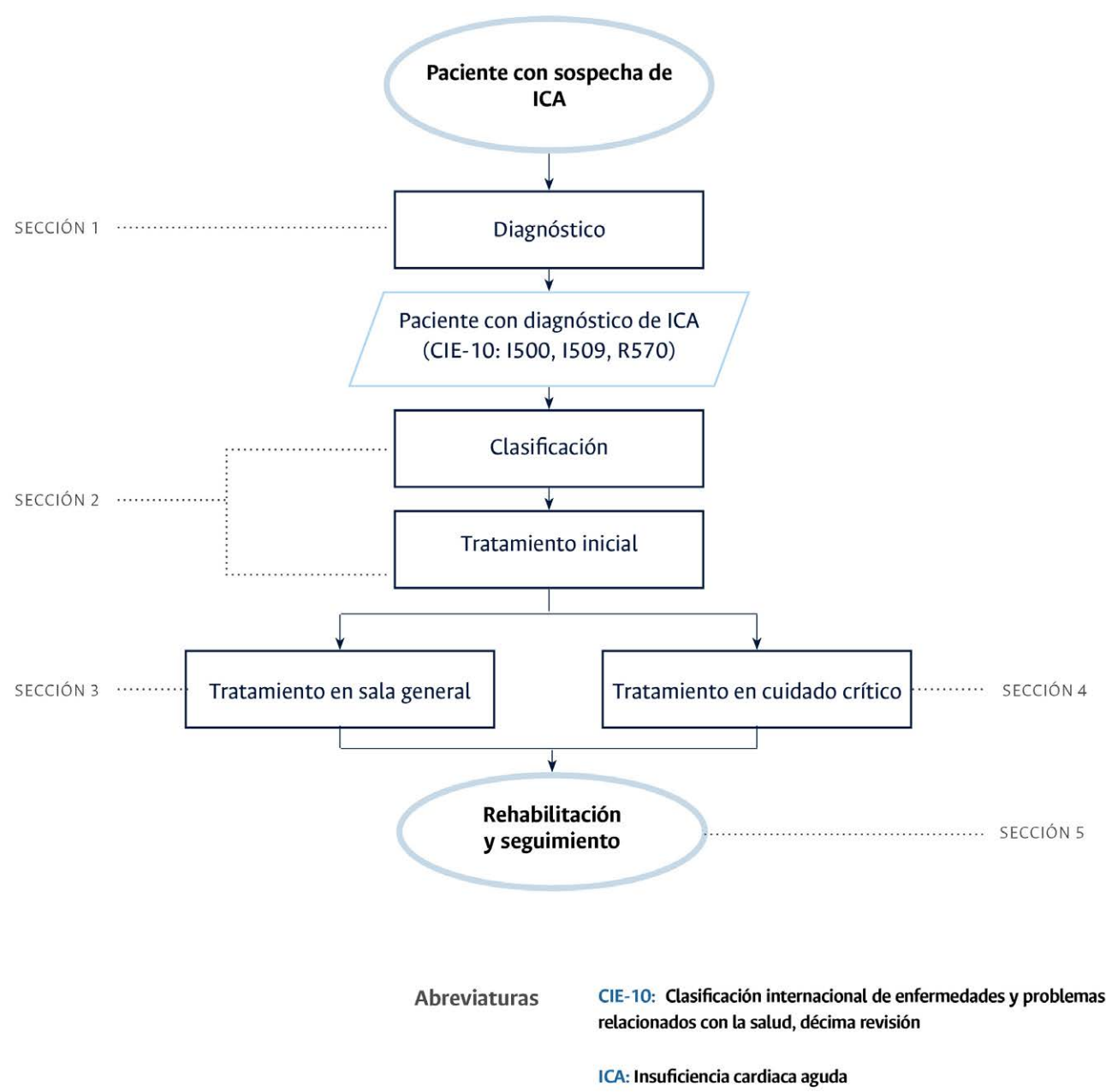
Se debe sospechar de ICA en el paciente con inicio o empeoramiento de síntomas secundarios a disfunción ventricular, dados por congestión y/o hipoperfusión. La evaluación paraclínica inicial comprende electrocardiograma, radiografía de tórax y ultrasonografía a la cabecera del paciente (POCUS, por sus siglas en inglés) o ecocardiograma. Dentro de los diagnósticos diferenciales se deben considerar enfermedades que se presentan con sobrecarga de volumen o disnea como la insuficiencia renal aguda, el síndrome de dificultad respiratoria, cirrosis, fibrosis pulmonar, síndrome nefrótico y embolia pulmonar. Se considera diagnostico confirmado cuando existe:

- Elevación de péptidos natriuréticos (NT-ProBNP o BNP) ajustando el punto de corte según la fracción de eyección ventricular (FEVI), ritmo de base y edad.
- Hallazgos ecocardiográficos como FEVI menor del 40% o FEVI mayor al 40% asociado a alteración funcional o estructural



ECBE diagnóstico y tratamiento del paciente adulto con insuficiencia cardiaca aguda en el Hospital Universitario Nacional de Colombia

Arnold Méndez Toro, Héctor Andrés Ruiz Ávila y Guillermo Mora Pabón
Líderes clínicos ECBE diagnóstico y tratamiento del paciente adulto con insuficiencia cardiaca aguda en el Hospital Universitario Nacional de Colombia.



CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO INICIAL

Una vez establecido el diagnóstico de ICA se reconocen dos fases:

- Fase urgente: Hasta los primeros 60 minutos, en ella debe realizarse la clasificación de Stevenson y fenotípica, además de la solicitud de las valoraciones por las especialidades pertinentes según el escenario clínico.
- Fase inmediata: de 60 a 120 minutos. Es fundamental en esta instancia determinar la presencia de choque cardiogénico o falla ventilatoria, la identificación del desencadenante y el requerimiento a ingreso a cuidado crítico.

La **clasificación de Stevenson** estratifica a los pacientes de acuerdo a la presencia o no de congestión como húmedo o seco, y de acuerdo a la presencia o no de hipoperfusión como caliente o frío. Se obtienen así 4 categorías:

- Clase I (A): Caliente-seco
- Clase II (B): Caliente-húmedo
- Clase III (C): Frío-húmedo
- Clase IV (L): Frío-seco

Si bien esta clasificación se correlaciona de manera adecuada con la fisiopatología, se ha descrito su pobre utilidad en la clínica por lo que se han establecido fenotipos que

permiten el enfoque terapéutico diferencial al distinguir entre congestión sistémica y pulmonar:

- Falla cardíaca agudamente descompensada: secundaria a disfunción ventricular izquierda con acumulación de líquido, en esta, el edema es la característica principal, requiriendo tratamiento farmacológico descongestivo con diuréticos.
- Edema pulmonar agudo: definido como la presencia de insuficiencia respiratoria aguda significativa en forma de taquipnea (frecuencia respiratoria [FR] >25), hipoxemia dada por saturación arterial de oxígeno [SpO2] menor del 90%), y aumentó del trabajo respiratorio en un paciente con ICA.
- Falla aislada del ventrículo derecho: compromiso únicamente del ventrículo derecho asociado como principal etiología a tromboembolismo pulmonar de alto riesgo o síndrome de dificultad respiratoria aguda.
- Choque cardiogénico: definido como hipotensión con signos clínicos o paraclínicos de hipoperfusión, secundario a disfunción ventricular. Representa la minoría de los pacientes; sin embargo, requiere un abordaje clínico y tecnológico avanzado por alta tasa de mortalidad incluyendo uso de inotrópicos y soporte mecánico circulatorio.

Siguiente página

TRATAMIENTO GENERAL

En abordaje inicial incluye:

- Monitorización de la SpO2
- Administración de oxigenoterapia si la saturación es menor a 90%
- Administración de tromboprofilaxis en ausencia de contraindicaciones
- Iniciar/ continuar tratamiento médico óptimo en ausencia de contraindicaciones
- Solicitar valoración por terapia física, terapia respiratoria y rehabilitación cardíaca
- Solicitar valoración por programa de salud cardiovascular
- Solicitar valoración por nutrición clínica

Adicionalmente, debe vigilarse los síntomas/signos de congestión para establecer requerimiento de tratamiento diurético o administración de líquidos, la respuesta clínica y los criterios de traslado a cuidado crítico

Se recomienda que el paciente hospitalizado por ICA sea evaluado cuidadosamente para excluir la insuficiencia cardíaca persistente

TRATAMIENTO EN CUIDADO CRÍTICO

Los criterios para la admisión a cuidado crítico incluyen cualquiera de los siguientes:

- Necesidad de ventilación mecánica invasiva
- Signos/síntomas de hipoperfusión
- SpO2 menor a 90%, a pesar del oxígeno suplementario
- Uso de músculos accesorios para la respiración, frecuencia respiratoria mayor a 25/min
- Frecuencia cardíaca < 40 o mayor a 130 lpm
- Presión arterial sistólica <90 mm Hg.
- Otros criterios determinados en el protocolo de ingreso a cuidado crítico institucional disponible en DARUMA.

EGRESO Y SEGUIMIENTO

Se recomienda que el paciente hospitalizado por ICA sea evaluado cuidadosamente para excluir la insuficiencia persistente con signos de congestión clínicos antes del alta, para optimizar el tratamiento oral con inicio previo al egreso.

Así mismo, se debe planificar el seguimiento 1 a 2 semanas posteriores al ingreso e ingreso a los programas de rehabilitación cardíaca ambulatoria y de salud cardiovascular.

#SOMOSHUN



Consulta el ECBE en la página web del HUN

<https://www.hun.edu.co/paciente-con-insuficiencia-cardiaca-aguda>

Siguiente nota



ORGULLO HUN es un tema **CLAVE**

Conoce la caracterización de la población en el HUN

Conocer a nuestros pacientes es fundamental porque nos permite identificar y comprender sus necesidades específicas de salud e información. Al analizar estos factores demográficos (edad, género, lugar de origen), socioeconómicos, culturales y epidemiológicos de la población atendida, planificamos su atención, asignando adecuadamente personal, tecnología y recursos financieros, asegurando que se adapten a las características de la comunidad atendida, de la misma forma diseñamos estrategias de comunicación y educación en salud, conociendo el nivel de comprensión, los idiomas predominantes y las costumbres de la población.

Los procesos de programas especiales y gestión de la Información desarrollaron el Observatorio de Salud, un aplicativo alojado en la INTRANET que contiene la caracterización de nuestra población en tiempo real. La caracterización permite entender mejor las condiciones de salud prevalentes, facilitando la detección de patrones de enfermedades específicas y permitiendo tratamientos más ajustados a las necesidades. Con esta información, se pueden anticipar y minimizar posibles dificultades que enfrenten los pacientes en el acceso a los servicios de salud, desde barreras idiomáticas hasta económicas.

ESTO HACE PARTE DE LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD

Consúltalo en la Intranet HUN





Siguiente nota

ESTAR CONECTADO CON EL HUN es un tema **CLAVE**

Calendario de eventos HUN



Charla académica en hepatología

Donación en asistolia controlada

Dr Iván Dario Martín

Cirujano de trasplante y hepatobiliar, Unidad de Enfermedades Hepática, Clínica Shaio

Jueves 7 de noviembre, 7:30 pm, virtual.



Capacitación en Farmacovigilancia

Dr. Julián Sánchez Médico Especializado, Integrante del Programa Distrital de Farmacovigilancia - Secretaria Distrital de Salud.

Jueves, 7 noviembre • 7:30 – 9:00pm

Capacitación virtual



Acreditación

Aterrizajes

Visitas de 5 minutos que realizan los emisarios del equipo EMI a todos los procesos.

Desde el 15 de octubre al 15 de noviembre



Capacitación en toma y embalaje de muestra para código blanco.

15 de noviembre 2024

Dirigido para Médicos y Jefes de enfermería.

De 8:00 AM a 11:00 AM • Auditorio A Y B.



Acreditación

Despliegue Secundario Acreditación

Salón A2, sesiones de 1 hora de manera continua

Del 5 al 7 de Noviembre • 7:00am – 4:00pm



Charla académica en hepatología

Trombosis portal: manejo endovascular

Dr Emilio Sanín, Radiólogo

Intervencionista, Hospital Pablo Tobón Uribe

Jueves 28 de noviembre, 7:30 pm, virtual



Acreditación

III Feria de la Acreditación

Hall principal y Edificio Administrativo

Del 12 al 15 de Noviembre



Acreditación

Visita de Evaluación del ICONTEC

Del 19 al 22 de Noviembre



VIGENCIA 2024

AL DÍA CON EL DIRECCIONAMIENTO

Conoce el cronograma de eventos de la Dirección General del HUN y participa en el avance hacia la **visión 2025**





LA DIRECCIÓN GENERAL PASA AL TABLERO

Participa en el avance hacia la **visión 2025** y entérate del avance del HUN

05

NOVIEMBRE

CONOCE LA ACTUALIDAD
DEL HUN

9:00 a.m. - 10:30 a.m.

 Conéctate vía
google meet 

06

NOVIEMBRE

CONOCE LA ACTUALIDAD
DEL HUN

1:30 p.m. - 3:00 p.m.

 Conéctate vía
google meet 

UN CAFÉ CON LA DIRECCIÓN

24

OCTUBRE

GESTIÓN
AMBULATORIA

21

NOVIEMBRE

GESTIÓN
COMERCIAL
Y MERCADEO

19

DICIEMBRE

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA



Recuerda que pese a que estos eventos ya esten agendados están sujetos a cambios según disponibilidad

CONOCE EL
CRONOGRAMA ACTUALIZADO
LINK EN LA INTRANET

¿Te gustó el nuevo diseño?
Cuéntanos que piensas al correo

comunicaciones@hun.edu.co

#Somos HUN

BOLETÍN

Ed. 190



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA